PROTOCOLO

ORIGEM	NÚMERO
Coordenação Médica de Tocoginecologia	

ASSUNTO	DATA
Protocolo de Diagnóstico e Conduta na Perda Gestacional Precoce	19/09/2026
	REVISÃO 002

Quadro de Revisões

NÚMERO	DATA	REVISÃO EFETUADA
002	05/11/2026	Figura 2 corrigida: os critérios definitivos de inviabilidade remetem ao Quadro 2 (antes, Quadro 1)
001	14/10/2026	Antibioticoprofilaxia no esvaziamento cirúrgico alterada para doxiciclina 200 mg VO (SFP 2025), item 4 e Quadro de doses
000	19/09/2026	Emissão inicial

TEMPO DE PERMANÊNCIA EM ARQUIVO: Indeterminado

Sumário

1. **INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA** 3
2. **OBJETIVO** 4
3. **CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE** 4
4. **CONTEÚDO CLÍNICO E ASSISTENCIAL** 5
5. **FLUXOGRAMA** 13

www.hes.unicamp.br
OSS FUNCAMP
Avenida da Amizade, 2.400. Parque Jatobá, Sumaré – SP.
CEP 13175-490 / (19) 3883-8900

6. RESPONSABILIDADES 18
7. INDICADORES 19
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 19
9. ANEXOS 21

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA

A perda gestacional precoce é a interrupção espontânea de uma gestação intrauterina no primeiro trimestre. É uma das intercorrências mais frequentes da gravidez: estima-se que 31% de todas as gestações e até 10% das gestações clinicamente reconhecidas terminem em abortamento espontâneo, e 80% das perdas ocorrem no primeiro trimestre [1].

O diagnóstico de inviabilidade é a decisão mais crítica do atendimento, porque o erro não tem reparação: o esvaziamento uterino de uma gestação que evoluiria é um dano irreversível, enquanto aguardar alguns dias por um novo exame não prejudica o desfecho da gestação [2,3]. Por isso, os critérios ultrassonográficos atuais foram escolhidos para ter falso-positivo praticamente nulo. Com os limiares antigos, a taxa de falso-positivo chegava a 4,4% para o diâmetro médio do saco gestacional (DMSG) de 16 mm e a 8,3% para o comprimento cabeça-nádega (CCN) de 5 mm [4]; os limiares de 25 mm e 7 mm, validados em coorte prospectiva de 2.845 mulheres, tiveram especificidade de 100% [5]. Esses critérios servem para confirmar a perda, não para excluí-la [6].

O exame clínico isolado é pouco acurado nesse cenário. Em ensaio clínico randomizado com gestantes estáveis no primeiro trimestre, o diagnóstico clínico coincidiu com o diagnóstico final em pouco mais da metade dos casos, e o toque vaginal não melhorou a acurácia [7]. Em estudo com o exame anatomopatológico como padrão-ouro, o estado do colo uterino (aberto ou fechado) teve sensibilidade de 65% e especificidade de 56% para detectar restos ovulares, e metade das pacientes com diagnóstico clínico de abortamento incompleto não tinha restos [8].

No Hospital Estadual de Sumaré (HES), a prática vigente de iniciar a avaliação pelo exame físico e solicitar a ultrassonografia (USG) apenas quando necessária, somada à indisponibilidade de USG nas 24 horas e à ausência de USG no Centro Obstétrico (CO), tornou necessário um protocolo que inverta essa lógica, padronize os critérios diagnósticos e estabeleça uma barreira objetiva contra o esvaziamento uterino sem diagnóstico confirmado.

2. OBJETIVO

Padronizar o diagnóstico e a conduta na perda gestacional precoce no Pronto Atendimento (PA) obstétrico e no CO do HES, garantindo que nenhum esvaziamento uterino seja realizado sem critério diagnóstico confirmado e conferido.

- Adotar a USG transvaginal como exame que define o diagnóstico e a conduta, com critérios de inviabilidade de alta especificidade.
- Eliminar o uso do colo uterino aberto ou fechado como critério para indicar esvaziamento.
- Instituir a conferência por dois médicos antes de todo esvaziamento uterino medicamentoso ou cirúrgico fora de urgência.
- Definir a conduta segura quando a USG não estiver disponível, inclusive a proteção contra gestação ectópica não diagnosticada.
- Padronizar os esquemas de misoprostol, a técnica de esvaziamento cirúrgico, a antibioticoprofilaxia e o seguimento.

3. CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE

3.1. Critérios de inclusão

- Gestantes com idade gestacional (IG) de até 13 semanas e 6 dias com sangramento vaginal.
- Gestantes de até 13 semanas e 6 dias encaminhadas com diagnóstico de gestação não evolutiva, com ou sem sangramento.

3.2. Critérios de exclusão e encaminhamento

- IG de 14 semanas ou mais: conduta obstétrica específica, fora deste protocolo.
- Gestação de localização desconhecida ou suspeita de gestação ectópica: segue os passos mínimos do item 4.5 e sai deste protocolo.
- Suspeita de gestação ectópica rota (instabilidade com dor abdominal ou sinais peritoneais): acionamento imediato da equipe cirúrgica.

3.3. Setores

Pronto Atendimento obstétrico e Centro Obstétrico do HES.

4. CONTEÚDO CLÍNICO E ASSISTENCIAL

4.1. Definições

Quadro 1 – Definições adotadas neste protocolo

Termo	Definição
Ameaça de abortamento	Gestação intrauterina com embrião com batimentos cardíacos (BCF) e sangramento vaginal.
Abortamento retido	Gestação intrauterina inviável pelos critérios definitivos do Quadro 2.
Abortamento incompleto	Material heterogêneo ou hiperecogênico na cavidade uterina, **sem** saco gestacional e **sem** embrião, em paciente com sangramento e com USG anterior que documentou gestação intrauterina.
Abortamento completo	Cavidade uterina vazia em paciente com USG anterior que documentou gestação intrauterina.
Abortamento infectado	Abortamento com sinais de infecção intrauterina (febre, secreção purulenta ou com odor fétido, dor uterina). Investigação: proteína C-reativa (PCR) e hemograma.
Gestação de localização desconhecida	Teste de gravidez positivo sem gestação intrauterina ou extrauterina visível à USG. Deve ser tratada como possível ectópica até que a localização seja definida [3].
Achado suspeito	Achado sugestivo de perda que **não** atinge critério definitivo (Quadro 3). Não autoriza intervenção.

Fonte: Adaptado da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (FEBRASGO) [1] e do National Institute for Health and Care Excellence (NICE) [3].

4.2. Avaliação inicial

A avaliação inicial compreende acolhimento, sinais vitais, avaliação hemodinâmica, exame especular e os exames laboratoriais de admissão. **O toque vaginal bimanual é dispensável**: não melhora a acurácia diagnóstica em pacientes estáveis [7] e sua omissão não aumentou a morbidade em ensaio clínico randomizado, embora este não tenha atingido o tamanho amostral planejado [9]; em gestação intrauterina documentada à USG, o exame pélvico não alterou a conduta [10] (recomendação condicional; certeza baixa).

O **exame especular é realizado em todas as pacientes**, para confirmar a origem do sangramento, identificar lesões cervicais ou vaginais e material no canal cervical.

www.hes.unicamp.br
OSS FUNCAMP
Avenida da Amizade, 2.400. Parque Jatobá, Sumaré – SP.
CEP 13175-490 / (19) 3883-8900

O colo uterino aberto ou fechado não é critério para indicar esvaziamento uterino. Diagnóstico e conduta são definidos pela USG transvaginal. Com a USG, o estado do colo pode ser desconsiderado [8].

Este protocolo diverge, neste ponto, do protocolo da FEBRASGO, que enfatiza o exame pélvico para definir a forma clínica do abortamento [1]. A decisão institucional baseia-se nos estudos comparativos citados acima.

Exames de admissão, para todas as pacientes: tipagem sanguínea ABO/Rh, hemograma e testes rápidos para sífilis e HIV [1]. Coagulograma se houver sangramento importante ou suspeita de coagulopatia.

4.3. Urgência

É urgência a paciente hemodinamicamente instável, com sangramento intenso ou com sinais de infecção. A instabilidade é caracterizada pela frequência cardíaca e pela pressão arterial; na suspeita de infecção, colher PCR e hemograma. Nesses casos o exame especular orienta a conduta imediata, e a USG é feita somente se não atrasar o tratamento [1,3]:

- **Sangramento uterino intenso** ao exame especular (saída de sangue pelo orifício cervical ou material no canal) ou **sinais de infecção**: estabilização (acesso venoso calibroso, cristaloide, oxigênio, analgesia) e esvaziamento uterino por aspiração, preferencialmente; curetagem apenas se a aspiração estiver indisponível. A conferência do Anexo 1 (item 4.7) é dispensada, com justificativa registrada em prontuário.
- **Instabilidade com dor abdominal ou sinais peritoneais e sangramento vaginal desproporcionalmente pequeno**: suspeita de gestação ectópica rota. Sai deste protocolo; acionar imediatamente a equipe cirúrgica.

No abortamento infectado, a antibioticoterapia precede o esvaziamento, que deve ser feito logo após o início do antibiótico e a estabilização hemodinâmica (Quadro 4) [1].

4.4. Quando a USG não está disponível

O HES não dispõe de USG nas 24 horas. Na paciente clinicamente estável (sangramento pequeno, frequência cardíaca e pressão arterial normais e estáveis, normocorada), a conduta é decidida entre a equipe e a paciente e registrada em prontuário:

- **Aguardar o exame em casa** somente se **todas** as condições estiverem presentes: ausência de dor abdominal, IG menor que 6 semanas pela data da última menstruação e ausência de fator de risco para gestação ectópica (ectópica prévia, cirurgia tubária, dispositivo intrauterino, reprodução assistida). Retorno com data e hora definidas e orientação escrita dos sinais de alarme (Anexo 2).
- Nas demais pacientes (dor, IG de 6 semanas ou mais, IG incerta ou fator de risco): **internar até a realização da USG**.

A restrição se justifica porque cerca de um terço das mulheres com gestação ectópica não tem fator de risco conhecido [3], e a dosagem quantitativa de gonadotrofina coriônica humana (β-hCG) no HES não fica disponível a tempo de orientar a decisão no PA.

Enquanto a localização da gestação não for definida por USG, **não se prescreve misoprostol nem se realiza esvaziamento uterino**.

4.5. Diagnóstico ultrassonográfico

A USG deve ser transvaginal. O laudo registra CCN, DMSG, presença de vesícula vitelina e presença ou ausência de BCF, e as imagens com as medidas são anexadas ao prontuário.

A USG transabdominal isolada não sustenta o diagnóstico de perda: se for o único exame possível, as medidas são registradas e o exame é repetido após no mínimo 14 dias [3].

O diagnóstico definitivo de abortamento retido segue os critérios da Society of Radiologists in Ultrasound (SRU), adotados pela FEBRASGO (Quadro 2) [1,2] (recomendação forte; certeza moderada).

Quadro 2 – Critérios ultrassonográficos definitivos de gestação inviável (USG transvaginal)

Critério
CCN ≥ 7 mm sem BCF
DMSG ≥ 25 mm sem embrião
Ausência de embrião com BCF ≥ 2 semanas após exame que mostrou saco gestacional sem vesícula vitelina
Ausência de embrião com BCF ≥ 11 dias após exame que mostrou saco gestacional com vesícula vitelina

Fonte: FEBRASGO [1]; Doubilet et al. [2].

Os limiares de 7 mm e 25 mm foram validados com especificidade de 100% [5], mas a variabilidade entre examinadores é relevante perto do limiar, e um único exame nunca é 100% seguro [3,11]. Por isso:

- **Paciente com sangramento**: a segunda opinião e/ou novo USG após no mínimo 7 dias, conforme o NICE [3], é opção válida **a critério do médico assistente**, considerando o benefício do novo exame e a carga emocional da espera.
- **Paciente sem sangramento** (em geral, encaminhada com diagnóstico de gestação não evolutiva): a segunda opinião e/ou novo USG após no mínimo 7 dias é **obrigatória** antes de qualquer intervenção, porque esses casos têm maior risco de corresponder a uma gestação inicial.

Achados sugestivos que não atingem critério definitivo (Quadro 3) **não autorizam intervenção**: a paciente recebe alta com orientação escrita e retorno agendado para nova USG [3,5,12].

www.hes.unicamp.br
OSS FUNCAMP
Avenida da Amizade, 2.400. Parque Jatobá, Sumaré – SP.
CEP 13175-490 / (19) 3883-8900

Quadro 3 – Achados suspeitos: não intervir, repetir USG

Achado	Novo USG
CCN < 7 mm sem BCF	Após 7 a 10 dias
DMSG de 16 a 24 mm sem embrião	Após 7 a 10 dias
DMSG < 16 mm sem embrião	Após no mínimo 7 dias; se DMSG < 12 mm, após no mínimo 14 dias
Ausência de embrião com BCF 7 a 13 dias após exame com saco sem vesícula vitelina, ou 7 a 10 dias após exame com saco com vesícula vitelina	Até completar o intervalo do Quadro 2
Ausência de embrião ≥ 6 semanas após a data da última menstruação	Após 7 a 10 dias
Âmnio vazio (âmnio junto à vesícula vitelina, sem embrião visível)	Após 7 a 10 dias
Vesícula vitelina aumentada (> 7 mm)	Após 7 a 10 dias
Saco gestacional pequeno para o embrião (DMSG − CCN < 5 mm)	Após 7 a 10 dias

Fonte: Adaptado de Doubilet et al. [2] (Tabela 2) e Preisler et al. [5].

Sem saco gestacional intrauterino à USG, a conduta depende de haver USG anterior que tenha documentado gestação intrauterina:

- **Sem USG anterior de gestação intrauterina**: tratar como gestação de localização desconhecida. Nunca prescrever misoprostol ou esvaziar. Material na cavidade não confirma abortamento incompleto: novo USG após no mínimo 7 dias [3]. Suspeita de ectópica: avaliação clínica pelo médico do plantão, priorizando os sintomas, dosagem seriada de β-hCG e orientação escrita dos sinais de alarme, fora deste protocolo [3].
- **Com USG anterior de gestação intrauterina** e material heterogêneo ou hiperecogênico na cavidade: abortamento incompleto. O achado de material hiperecogênico é o melhor preditor de restos ovulares [13]; a espessura endometrial isolada não define o diagnóstico, por não haver limiar confiável [14].
- **Com USG anterior de gestação intrauterina** e cavidade vazia: abortamento completo (item 4.9).

www.hes.unicamp.br
OSS FUNCAMP
Avenida da Amizade, 2.400. Parque Jatobá, Sumaré – SP.
CEP 13175-490 / (19) 3883-8900

4.6. Conduta após o diagnóstico confirmado

Confirmado o abortamento retido ou incompleto, fora de urgência, a **conduta expectante por 7 a 14 dias é a primeira linha**, para reduzir os riscos dos procedimentos, já que existe chance de eliminação espontânea [3] (recomendação condicional; certeza moderada). A paciente recebe alta com orientação escrita e retorno agendado ao PA/CO com USG.

O esvaziamento medicamentoso ou cirúrgico é indicado quando a conduta expectante não for aceitável para a paciente ou quando houver [3]:

- risco aumentado de hemorragia (por exemplo, final do primeiro trimestre);
- experiência adversa ou traumática em gestação anterior (óbito fetal, abortamento, hemorragia anteparto);
- risco aumentado pelos efeitos de uma hemorragia (coagulopatia, recusa de transfusão);
- sinais de infecção (ver item 4.3).

4.6.1. Esvaziamento medicamentoso

Misoprostol 800 mcg via vaginal (4 comprimidos de 200 mcg); sem expulsão, repetir 800 mcg após intervalo mínimo de 3 horas, até 3 doses no total, com a paciente internada (Quadro 4) [1,12,15] (recomendação forte; certeza moderada). O mesmo esquema é usado no abortamento retido e no incompleto, para padronizar a prescrição [3]. Doses menores são menos eficazes [16]. Após a última dose, a paciente é reavaliada e recebe alta com orientações se estiver estável, mesmo sem expulsão completa. No Brasil não se dispõe de mifepristona, e o misoprostol está disponível apenas em ambiente hospitalar [1]. Não há indicação de antibioticoprofilaxia no esvaziamento medicamentoso [15,17].

4.6.2. Esvaziamento cirúrgico

A técnica de escolha é a **aspiração intrauterina** (aspiração manual intrauterina (AMIU) ou aspiração elétrica). A curetagem uterina só é realizada se a aspiração estiver indisponível no plantão, com o motivo registrado em prontuário, e não se faz revisão com cureta após a aspiração [1,15] (recomendação forte; certeza baixa a moderada).

Antibioticoprofilaxia em todo esvaziamento cirúrgico [15,17,18] (recomendação forte; certeza alta): doxiciclina 200 mg por via oral, dose única, antes da instrumentação, até 2 horas antes

do procedimento [17] (recomendação forte; certeza moderada). Na alergia ou intolerância à doxiciclina, usar azitromicina 500 mg por via oral, dose única, no mesmo horário [17]. A profilaxia não é mantida após o procedimento [17].

4.7. Barreira de segurança: conferência por dois médicos

Nenhum esvaziamento uterino medicamentoso ou cirúrgico fora de urgência é realizado sem o Formulário de Conferência de Critérios (Anexo 1) preenchido, assinado e carimbado pelo médico assistente e conferido, assinado e carimbado por outro médico do plantão.

A regra vale para a prescrição de misoprostol e para a solicitação de AMIU, aspiração elétrica ou curetagem, no abortamento retido e no incompleto. O médico conferente não pode ser residente. Se, após o misoprostol, for necessário o esvaziamento cirúrgico, o mesmo formulário é válido e não precisa ser preenchido novamente. Os exames que sustentam o diagnóstico e a decisão da paciente são registrados em prontuário. Nos casos de urgência (item 4.3), a conferência é dispensada, com justificativa registrada em prontuário.

4.8. Medidas para todas as pacientes

- **Imunoglobulina anti-D**: não administrar antes de 12 semanas completas (IG pela USG). De 12 semanas a 13 semanas e 6 dias, administrar a gestantes Rh-negativas não sensibilizadas submetidas a esvaziamento medicamentoso ou cirúrgico [3,15,19,20] (recomendação forte; certeza muito baixa). Este protocolo diverge da FEBRASGO, que recomenda a profilaxia também antes de 12 semanas [1], e da Society for Maternal-Fetal Medicine [21].
- **Exame anatomopatológico** de todo material obtido, cirúrgico ou expelido no hospital [1].
- **Analgesia e antiemético** no esvaziamento medicamentoso: cetoprofeno e dipirona; metoclopramida como antiemético de primeira escolha e ondansetrona como alternativa (Quadro 4) [3].
- **Acolhimento**: comunicar o diagnóstico com privacidade e linguagem clara, oferecer apoio psicológico e informação escrita [1,3].

Quadro 4 – Medicamentos e doses

Indicação	Medicamento e dose	Observações
Esvaziamento medicamentoso (retido e incompleto)	Misoprostol 800 mcg (4 cp de 200 mcg) via vaginal; repetir 800 mcg após ≥ 3 horas se não houver expulsão; máximo de 3 doses	Somente com o Anexo 1 conferido. Paciente internada
Profilaxia no esvaziamento cirúrgico	Doxiciclina 200 mg VO, dose única, antes da instrumentação, até 2 horas antes	Alergia ou intolerância à doxiciclina: azitromicina 500 mg VO, dose única. Não usar no esvaziamento medicamentoso
Abortamento infectado	Gentamicina 1,5 mg/kg EV 8/8h ou 4,5 mg/kg EV 1 vez ao dia + clindamicina 900 mg EV 8/8h	Casos graves: associar ampicilina ou penicilina; clindamicina pode ser substituída por metronidazol. Manter EV até 48 horas afebril e com melhora clínica
Analgesia	Cetoprofeno 100 mg EV 12/12h (máximo 200 mg/dia) + dipirona 1 g EV 6/6h	
Náuseas e vômitos	Metoclopramida 10 mg EV; alternativa: ondansetrona 4 a 8 mg EV	Ondansetrona se falha ou intolerância à metoclopramida
Imunoglobulina anti-D	Dose disponível no HES (mínimo 250 UI / 50 mcg)	Apenas Rh-negativa não sensibilizada, IG 12+0 a 13+6 semanas, com esvaziamento

Fonte: FEBRASGO [1]; Organização Mundial da Saúde (OMS) [15]; NICE [3]; Society of Family Planning (SFP) [17]; padronização do HES.
EV: endovenoso; VO: via oral; UI: unidades internacionais.

4.9. Alta e seguimento

- **Ameaça de abortamento**: orientação e retorno ao pré-natal; retornar se o sangramento piorar ou persistir por mais de 14 dias. Não se prescreve progesterona de rotina [1,3].
- **Conduta expectante**: retorno agendado ao PA/CO em 7 a 14 dias para USG e nova decisão; retorno antes se houver sangramento intenso, dor ou febre [3].
- **Após expulsão** (expectante, medicamentosa) **e abortamento completo**: a confirmação é clínica, pela resolução do sangramento e da dor. O hospital fornece teste urinário de gravidez para ser feito em casa 3 semanas depois; se positivo, ou se houver sangramento intenso, dor ou febre mesmo com teste negativo, a paciente retorna para USG e reavaliação [3]. Não se faz USG de

controle de rotina: coágulos logo após a expulsão podem ser confundidos com restos e motivar procedimentos desnecessários [1].

- **Após esvaziamento cirúrgico não complicado**: não há necessidade de retorno de rotina; a paciente recebe orientação escrita dos sinais de alarme [15].
- Toda paciente recebe a orientação escrita de alta (Anexo 2).

5. FLUXOGRAMA

O fluxo assistencial está representado em quatro figuras: triagem (Figura 1), interpretação da USG com saco gestacional intrauterino (Figura 2) e sem saco gestacional (Figura 3), e conduta após o diagnóstico (Figura 4).

www.hes.unicamp.br
OSS FUNCAMP
Avenida da Amizade, 2.400. Parque Jatobá, Sumaré – SP.
CEP 13175-490 / (19) 3883-8900

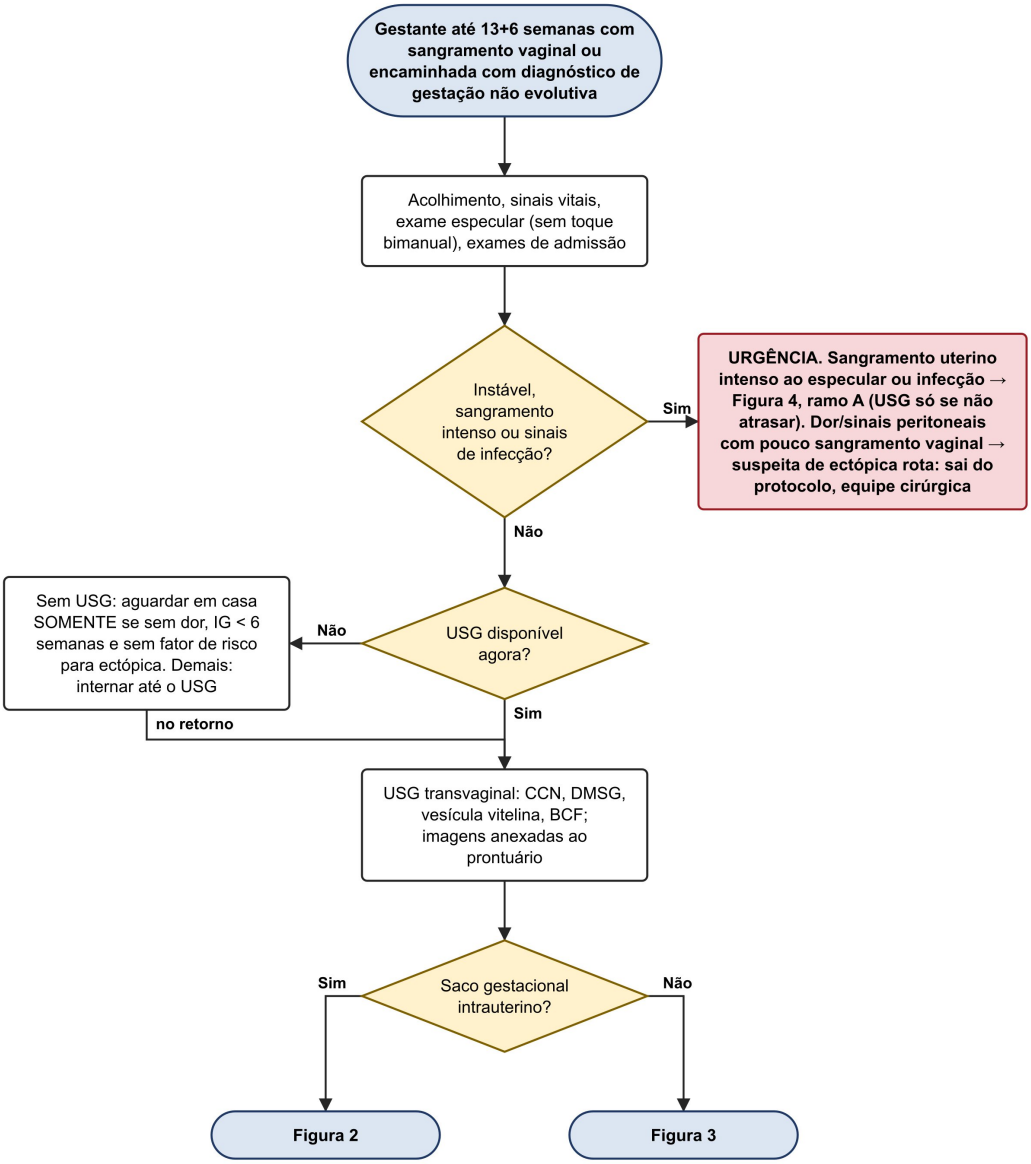


Figura 1 – Triagem da gestante no primeiro trimestre com sangramento ou diagnóstico de gestação não evolutiva
Fonte: Elaborado pelo autor.

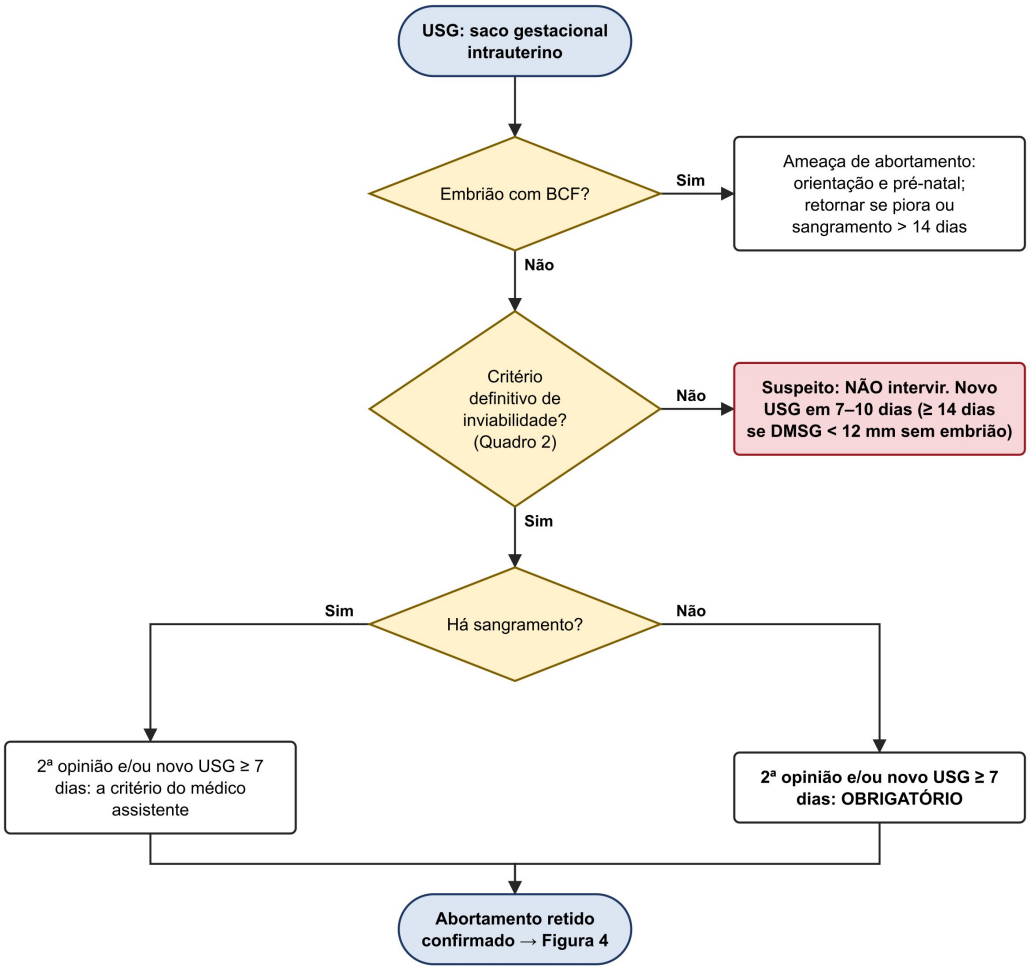


Figura 2 – Interpretação da USG com saco gestacional intrauterino
Fonte: Elaborado pelo autor.

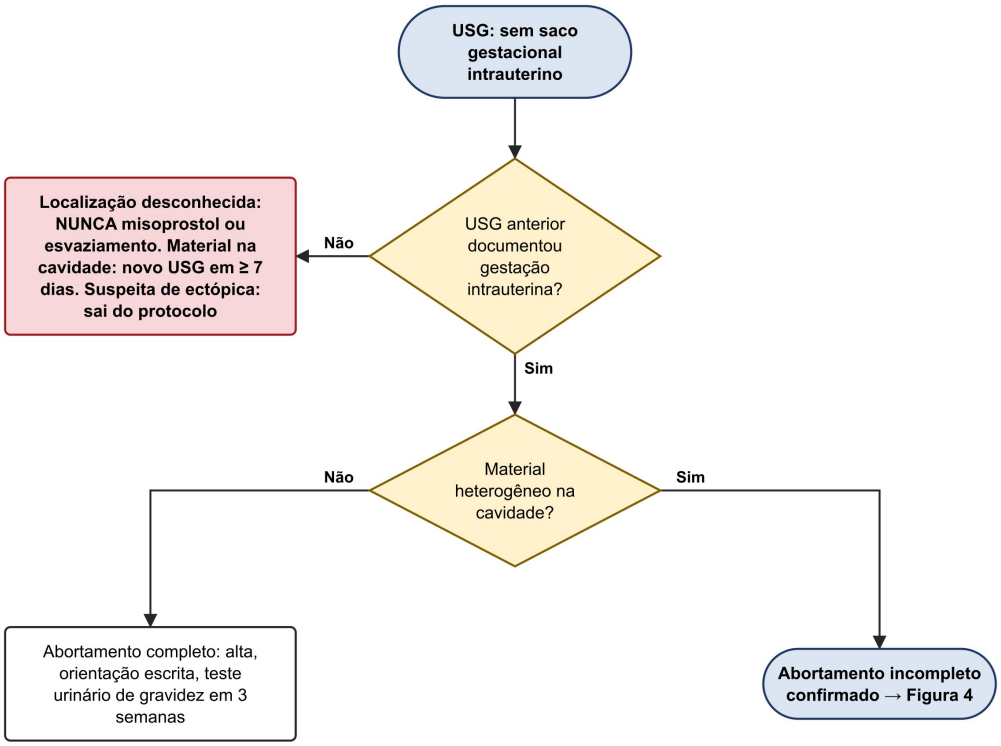


Figura 3 – Interpretação da USG sem saco gestacional intrauterino
Fonte: Elaborado pelo autor.

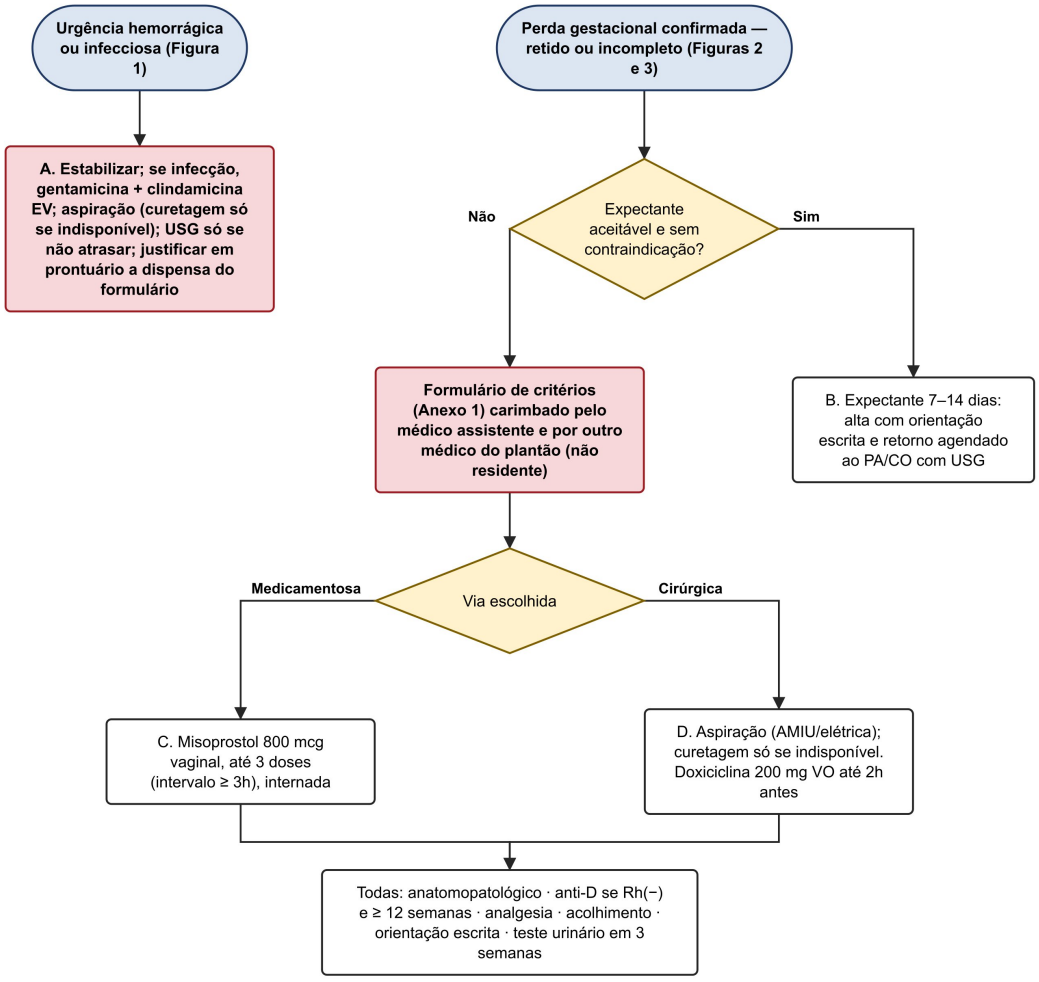


Figura 4 – Conduta após o diagnóstico de perda gestacional precoce
Fonte: Elaborado pelo autor.

6. RESPONSABILIDADES

Quadro 5 – Responsabilidades por função

Função	Atribuições
Médico assistente do plantão	Conduzir a avaliação inicial sem toque bimanual; realizar o exame especular; solicitar a USG transvaginal e os exames de admissão; classificar o achado da USG pelos critérios deste protocolo; decidir a conduta com a paciente e registrá-la em prontuário; preencher, assinar e carimbar o Anexo 1 antes de todo esvaziamento fora de urgência; entregar e explicar a orientação escrita de alta e, quando indicado, o teste urinário de gravidez.
Médico conferente (outro médico do plantão, não residente)	Conferir o critério diagnóstico assinalado com o laudo e as imagens da USG antes do esvaziamento; assinar e carimbar o Anexo 1; recusar a conferência se o critério não estiver documentado.
Médico residente	Participar do atendimento sob supervisão do médico assistente, seguindo este protocolo. Não atua como médico conferente.
Médico ultrassonografista	Realizar USG transvaginal com registro de CCN, DMSG, vesícula vitelina e BCF, e anexar as imagens com as medidas ao prontuário.
Enfermagem obstétrica	Acolher a paciente; aferir sinais vitais e comunicar alterações; administrar e registrar as medicações prescritas; reforçar as orientações escritas.
Farmácia	Dispensar misoprostol para esvaziamento fora de urgência somente mediante o Anexo 1 conferido e carimbado.
Coordenação Médica de Tocoginecologia	Treinar as equipes neste protocolo, com registro de presença; monitorar os indicadores; revisar o protocolo a cada 2 anos ou quando houver mudança de evidência ou de estrutura.

Fonte: Elaborado pelo autor.

7. INDICADORES

Quadro 6 – Indicadores de monitoramento

Indicador	Fórmula	Meta	Periodicidade e fonte
Adesão à conferência do Anexo 1	Esvaziamentos fora de urgência com Anexo 1 completo, carimbado pelo médico assistente e pelo conferente ÷ esvaziamentos fora de urgência × 100	100%	Mensal; auditoria de prontuário e farmácia
Esvaziamento em gestação evolutiva	Número de esvaziamentos uterinos realizados em gestação que se mostrou evolutiva	Zero	Mensal; notificações ao Núcleo de Segurança do Paciente
Aspiração como técnica de esvaziamento cirúrgico	Esvaziamentos cirúrgicos por aspiração ÷ esvaziamentos cirúrgicos × 100	Linha de base no primeiro semestre	Mensal; descrição cirúrgica
Seguimento dos achados suspeitos	Achados suspeitos com retorno para nova USG agendado ÷ achados suspeitos × 100	≥ 90%	Mensal; prontuário e agenda

Fonte: Elaborado pelo autor.

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Abortamento espontâneo: classificação, diagnóstico e conduta. São Paulo: FEBRASGO; 2021. (Protocolo FEBRASGO – Obstetrícia, nº 1/Comissão Nacional Especializada em Assistência ao Abortamento, Parto e Puerpério).

2. Doubilet PM, Benson CB, Bourne T, Blaivas M. Diagnostic criteria for nonviable pregnancy early in the first trimester. N Engl J Med. 2013;369(15):1443-51. doi:10.1056/NEJMra1302417

3. National Institute for Health and Care Excellence. Ectopic pregnancy and miscarriage: diagnosis and initial management (NG126). London: NICE; 2019 [atualizado 17 jun 2026; citado 30 set 2026]. Disponível em: https://www.nice.org.uk/guidance/ng126

4. Abdallah Y, Daemen A, Kirk E, Pexsters A, Naji O, Stalder C, et al. Limitations of current definitions of miscarriage using mean gestational sac diameter and crown-rump length measurements: a multicenter observational study. Ultrasound Obstet Gynecol. 2011;38(5):497-502. doi:10.1002/uog.10109

5. Preisler J, Kopeika J, Ismail L, Vathanan V, Farren J, Abdallah Y, et al. Defining safe criteria to diagnose miscarriage: prospective observational multicentre study. BMJ. 2015:h4579. doi:10.1136/bmj.h4579

6. Kalantari H, Hassen GW, Hanuscin CR, Zehtabchi S. Ultrasound measurements of gestational sac diameter and crown-rump length in intrauterine pregnancy of uncertain prognosis: a systematic review. Ultrasound. 2026. doi:10.1177/1742271X261462478

7. Johnstone C. Vaginal examination does not improve diagnostic accuracy in early pregnancy bleeding. Emerg Med Australas. 2013;25(3):219-21. doi:10.1111/1742-6723.12068

8. Wong SF, Lam MH, Ho LC. Transvaginal sonography in the detection of retained products of conception after first-trimester spontaneous abortion. J Clin Ultrasound. 2002;30(7):428-32. doi:10.1002/jcu.10086

9. Linden JA, Grimmnitz B, Hagopian L, Breaud AH, Langlois BK, Nelson KP, et al. Is the pelvic examination still crucial in patients presenting to the emergency department with vaginal bleeding or abdominal pain when an intrauterine pregnancy is identified on ultrasonography? A randomized controlled trial. Ann Emerg Med. 2017;70(6):825-34. doi:10.1016/j.annemergmed.2017.07.487

10. Seymour A, Abebe H, Pavlik D, Sacchetti A. Pelvic examination is unnecessary in pregnant patients with a normal bedside ultrasound. Am J Emerg Med. 2010;28(2):213-6. doi:10.1016/j.ajem.2008.10.018

11. Jurkovic D. Re: Limitations of current definitions of miscarriage using mean gestational sac diameter and crown-rump length measurements: a multicenter observational study. Ultrasound Obstet Gynecol. 2012;39(3):361. doi:10.1002/uog.11107

12. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No. 200: early pregnancy loss. Obstet Gynecol. 2018;132(5):e197-207. doi:10.1097/AOG.0000000000002899

13. Abbasi S, Jamal A, Eslamian L, Marsousi V. Role of clinical and ultrasound findings in the diagnosis of retained products of conception. Ultrasound Obstet Gynecol. 2008;32(5):704-7. doi:10.1002/uog.5391

14. Sundararajan S, Roy S, Polanski LT. The accuracy of ultrasound scan in diagnosing retained products of conception: a systematic review and meta-analysis. Am J Obstet Gynecol. 2024;230(5):512-31.e3. doi:10.1016/j.ajog.2023.11.1243

15. World Health Organization. Abortion care guideline. Geneva: WHO; 2022.

16. Wu HL, Marwah S, Wang P, Wang QM, Chen XW. Misoprostol for medical treatment of missed abortion: a systematic review and network meta-analysis. Sci Rep. 2017;7(1). doi:10.1038/s41598-017-01892-0

17. Cheng T, Kumar N, Laursen L, Achilles SL, Reeves MF. Society of Family Planning Clinical Recommendation: prevention of infection after abortion and pregnancy loss. Contraception. 2025;148:110895. doi:10.1016/j.contraception.2025.110895

18. Lissauer D, Wilson A, Hewitt CA, Middleton L, Bishop JR, Daniels J, et al. A randomized trial of prophylactic antibiotics for miscarriage surgery. N Engl J Med. 2019;380(11):1012-21. doi:10.1056/NEJMoa1808817

19. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Clinical Practice Update: Rh D immune globulin administration after abortion or pregnancy loss at less than 12 weeks of gestation. Obstet Gynecol. 2024;144(6):e140-3. doi:10.1097/AOG.0000000000005733

20. Maurice P, Vigoureux S, Garabedian C, Sibiude J, Sananès N. Prevention of RhD alloimmunization in the first trimester of pregnancy: clinical practice guidelines of the French College of Obstetricians and Gynecologists. Int J Gynaecol Obstet. 2025;171(1):63-71. doi:10.1002/ijgo.70166

21. Prabhu M, Louis JM, Kuller JA. Society for Maternal-Fetal Medicine Statement: RhD immune globulin after spontaneous or induced abortion less than 12 weeks of gestation. Am J Obstet Gynecol. 2024;230(5):B2-5. doi:10.1016/j.ajog.2024.02.288

9. ANEXOS

9.1. Anexo 1 – Formulário de Conferência de Critérios para Esvaziamento Uterino

Quadro 7 – Formulário de Conferência de Critérios para Esvaziamento Uterino (fora de urgência)

Preencher antes da prescrição de misoprostol ou da solicitação de aspiração/curetagem (fora de urgência)
Paciente: _____ Prontuário: _____ Data: ___/___/_____ Hora: ___h___
Critério diagnóstico atingido (assinalar)
( ) CCN ≥ 7 mm sem BCF ( ) DMSG ≥ 25 mm sem embrião ( ) Ausência de embrião com BCF ≥ 2 semanas após exame com saco gestacional sem vesícula vitelina ( ) Ausência de embrião com BCF ≥ 11 dias após exame com saco gestacional com vesícula vitelina ( ) Abortamento incompleto: sem saco gestacional e sem embrião + material heterogêneo na cavidade, com USG anterior de gestação intrauterina (data: ____/____/_____)
Conferência
Médico assistente: _____ assinatura e carimbo Médico conferente (não residente): _____ assinatura e carimbo

Fonte: Elaborado pelo autor.
Se, após o misoprostol, for necessário esvaziamento cirúrgico, este formulário continua válido.

9.2. Anexo 2 – Orientação escrita de alta

Você foi atendida no Hospital Estadual de Sumaré por sangramento ou por alteração no início da gestação. Siga as orientações abaixo e guarde este papel.

- Retorno agendado: ____/____/_____ às ____h____, no Pronto Atendimento obstétrico, para: ( ) ultrassonografia ( ) reavaliação.
- Teste de gravidez de urina em 3 semanas (se entregue): data ____/____/_____. Se der positivo, volte ao hospital.
- É esperado ter cólicas e sangramento parecido com menstruação por alguns dias.

Volte imediatamente ao hospital se tiver: sangramento intenso; dor forte na barriga que não melhora com o remédio; dor no ombro; desmaio ou tontura forte; febre (temperatura de 37,8 °C ou mais) ou corrimento com mau cheiro.

Atendimento 24 horas: Pronto Atendimento obstétrico do Hospital Estadual de Sumaré — Avenida da Amizade, 2.400, Parque Jatobá, Sumaré. Telefone: (19) 3883-8900.